

MAICO CUSTODIO DOS SANTOS				
MEDICAMENTOS:	185kg.			
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência			
BANHEIRO	3x			
HORA QUE ACORDA	6h			
HORA QUE DORME	23:30			
PRATICA EXERCICIO	Ainda não			
HORARIO DAS REFEIÇÕES				
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:	
05/23	22201668390 / 998	- w.m		
13/06	P= 5-15cmH ₂ O	médio	⇒ P= 11.8 cmH ₂ O	
22	IAH= 1.3fr			
	m. de uso: 7h 25'			
	Bem adaptado			Jua
28/06	P= 5-12cmH ₂ O			
22	IAH= 0,8 l/min			
	m. de uso: 6h 30'			
	Bem adaptado			Jua
	não está indo ao banheiro			
	melhora da relação da glicemia			
12/08	P= 5-12,6cmH ₂ O			
22	IAH= 0,9 l/min			
	m. de uso: 6h 45'			
15/10	P= 5- 12.3cmH ₂ O			
22	IAH= 0,6 l/min			
	m. de uso: 6h 30'			
	Fuga= 23,1 l/min			
	Bem adaptado, relata			
	ba sonolência diurna			
	Não mudou medicação.			
	mas está dormindo + tarde			
	Jua			
18/11	P= 12.0 cmH ₂ O			
22	IAH= 0,6 elu			
	m. de uso: 6h 29'			
	Fuga= 27 l/min			
	Bem adaptado, relata			
	melhora da sonolência			
	da diurna			
	Oculto a perda de peso, 183kg			Jua
20/01	P= 11.3cmH ₂ O			
23	IAH= 1.4 elu			
	m. de uso: 5h 40'			
	m. de fuga= 29.7 l/min.			
	P= 173 Kg			
28/03	P= 7.7 médio			
23	fuga 8.4 elu			
	m. de uso: 5h 52'			
	relata escape de ar /			
	Peso = 164kg			
	Jua			

NS

MAICO CUSTODIO

SINTOMAS/ QUEIXA: sonolência / S/ edema mmIS.
 MEDICAMENTOS: glifage / simvastatina / Furox emido
 Inalapius

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 06hs
 P= 170 Kg.

BANHEIRO: OX

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

EXERCÍCIO FÍSICO: não

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

PESO: ALTURA: IAH: MALLAMPATI: SPO2:

10/05 máscara escapa mais ar, SIC. (swift)
 23 P= 7.5 - 10.4 P95% precisa se
 m. de uso: 5h12' acostumar (fue)

07/05 P= 5 - 11 cmH₂O 7.8 cm H₂O (mediana)
 24 m de uso: 6h10m Peso: 165 Kg

IAH = 0.6 cl/h

fuga: 11 l/m (mediana) Rem adaptado

Esta cl acompanhamento
 da fone, bulata melhora Natacha
 no escape de ar.

11/03/25 P= 6.5 cmH₂O (med) P95: 9 cmH₂O
 IAH = 0.8 cl/h

m de uso: 7h7'

fuga: 29 l/m (P95) Rem adaptado

Natacha

Nome: MAICO CUSTODIO DOS SANTOS
Data de Nascimento: 11-5-1979
IMC: 51,25
Sexo: Masculino
Data do exame: 09-04-2022

Peso: 185 kg
Altura: 1,90 m
Médico: DR. ALVARO NAKANO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 09-04-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

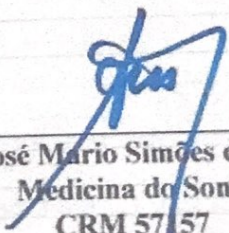
O tempo total de registro foi de 500,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 22,5 e 86,0 minutos. O tempo total de sono foi de 412,5, eficiência de 82,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,4%; estágio N2: 64,6%; estágio N3: 12,2%; sono REM: 19,8%. O índice de despertares foi de 39,6/hora (normal < 10/h). O índice de apneia/hipopneia total foi de 65,0/hora, sendo elas 16 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 431 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 57%, permanecendo 20,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 84 - 128 bpm e NREM de 87 - 127 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 12 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.
Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: **MAICO CUSTODIO DOS SANTOS**

Sexo: M	Idade: 42 anos	Peso: 185 Kg	Altura: 1,90 m
IMC: 51,2	Data do Exame: 05/03/2022	Exame: 11438_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 21:30:21 horas e encerrado às 06:03:00 horas, com latência para o sono de 114 minutos e latência para o sono REM de 111 minutos. O tempo total de sono foi de 365,5 minutos, com eficiência do sono de 71,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	4,5%	Até 5%
Estágio 2	68,0%	45 - 55%
Estágio 3	11,1%	> 15%
Sono REM	16,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	71,2%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 93 minutos ocorreram **283 despertares** (índice de 46,5 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 100 bpm, a maior de 120 bpm e a menor de 88 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 482 eventos respiratórios, sendo 0 central e 482 obstrutivos. Sendo 46 apnéias, 436 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 79,1/hora**, sendo 7,6 apnéia/hora e 71,6 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 21,3 e a duração máxima de 66,4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 74,0/hora, sendo 9,0 apnéia/hora e 65,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 97%, sendo a saturação média de 93%, a maior de 99% e a mínima de 49%, permanecendo 78,7 minutos (15,3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 11,2 minutos (2,2%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 670 dessaturações. Índice de dessaturações: 110,0/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 173,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 98,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200